

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

EVALUACIÓN BREVE DE ALFABETIZACIÓN EN SALUD (SAHLSA-50)

Short Assessment of Health Literacy for Spanish Adults (Lee et al., 2006) · Validación AHRQ / NCFH

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL Y FICHA RESUMEN

Nombre oficial	Evaluación Breve de Alfabetización en Salud para Adultos de Habla Hispana (SAHLSA-50)
Sigla / Acrónimo	SAHLSA-50 (Short Assessment of Health Literacy for Spanish Adults)
Autoría original	Shoou-Yih Daniel Lee, Deborah E. Bender, Rosa E. Ruiz & Young Ik Cho (2006)
Marco institucional	Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) y National Center for Farmworker Health (NCFH)
Constructo evaluado	Alfabetización funcional objetiva en salud: capacidad de lectura, pronunciación y comprensión semántica de vocabulario médico común
Población diana	Adultos hispanohablantes en atención primaria, servicios de urgencias, cribados sociosanitarios o investigación
Tiempo de aplicación	3 a 6 minutos (heteroadministrado mediante prueba estructurada con tarjetas o láminas)
Estructura y formato	50 términos médicos presentados con una palabra clave, una opción correcta de asociación y un distractor
Condiciones de uso	Dominio público / Acceso abierto para práctica clínica y epidemiológica no comercial (AHRQ)

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

A diferencia de los instrumentos de autoinforme subjetivo (como el HLS-EU-Q16 o el eHEALS, donde el paciente califica qué tan fácil cree que le resultan ciertas tareas), el SAHLSA-50 es una prueba objetiva de rendimiento basada en la ejecución real (**performance-based test**). Fue desarrollado como una adaptación transcultural rigurosa del clásico REALM (**Rapid Estimate of Adult Literacy in Medicine**), solventando el problema intrínseco del idioma español, donde la ortografía casi fonética permite una pronunciación mecánica correcta sin que medie una verdadera comprensión del significado.

Para garantizar que el sujeto realmente comprende los conceptos médicos habituales, el diseño del SAHLSA-50 combina una prueba de lectura en voz alta con una tarea de asociación conceptual de elección forzosa (**multiple choice**). Un término solo se puntúa como correcto si el paciente lo pronuncia adecuadamente Y selecciona la palabra asociada semánticamente correcta, descartando el término distractor.

3. ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LOS 50 TÉRMINOS BIOMÉDICOS

Término Clave	Opción Correcta	Distractor	Criterio de Acierto
Riñón	Orina	Fiebre	Pronunciar y asociar a "Orina"
Hemorroides	Venas	Corazón	Pronunciar y asociar a "Venas"
Próstata	Glándula	Garganta	Pronunciar y asociar a "Glándula"
Nervio	Sentimiento	Caminar	Pronunciar y asociar a "Sentimiento"
Diabetes	Azúcar	Grasa	Pronunciar y asociar a "Azúcar"
Hipertensión	Presión alta	Cansancio	Pronunciar y asociar a "Presión alta"
Ictericia	Amarillo	Hinchazón	Pronunciar y asociar a "Amarillo"
43 términos más	Términos semánticos	Distractor neutro	Puntuación 0 o 1 por término

EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA, BAREMACIÓN Y CÓMPUTO CLÍNICO

4. PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y RENDIMIENTO EN POBLACIÓN HISPANA

Consistencia interna	Excelente consistencia global; alfa de Cronbach $\alpha = 0.92$ en la muestra de desarrollo de Lee et al. (2006) en población hispana.
Estabilidad temporal	Fiabilidad test-retest a 2 semanas con coeficiente de correlación de Pearson $r = 0.88$, demostrando solidez métrica como prueba de rendimiento.
Validez de criterio	Correlación muy alta con el TOFHLA en español (Test of Functional Health Literacy in Adults , $r = 0.81$, $p < 0.001$).
Validez discriminante	Correlación moderada con los años de educación formal ($r = 0.46$), lo que demuestra que mide alfabetización funcional médica específica y no mero nivel escolar.
Rendimiento diagnóstico	Sensibilidad del 85% y especificidad del 80% para detectar pacientes que no son capaces de comprender instrucciones de alta médica o prospectos de fármacos.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

Administración individual	El examinador muestra al paciente una tarjeta o lámina con la palabra clave arriba y dos opciones abajo (más la opción "No sé").
Criterio estricto de acierto	Para obtener 1 punto , el examinado debe: 1) Pronunciar correctamente la palabra clave; Y 2) Señalar verbalmente o con el dedo la opción asociada correcta. Si falla en la pronunciación o en la asociación, se asigna 0 puntos .
Puntuación directa total	Suma aritmética directa de los aciertos válidos. Rango teórico posible: 0 a 50 puntos .
Gestión de dudas	Si el sujeto duda más de 5 segundos en un término, se le pide que intente el siguiente sin penalización en el resto de la prueba.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Puntuación	Distribución	Nivel de Alfabetización	Significación Clínica y Capacidad Funcional
0 - 37 puntos	Aprox. 20 - 25%	Baja Alfabetización en Salud	Incapacidad para interpretar etiquetas de medicamentos y consentimientos.
38 - 50 puntos	Aprox. 75 - 80%	Alfabetización Adecuada	Habilidad suficiente para comprender la información médica ambulatoria.

PUNTO DE CORTE CANÓNICO OFICIAL (LEE ET AL., 2006; AHRQ):

- **SAHLSA-50 ≤ 37 puntos:** Define la presencia de **Baja Alfabetización en Salud (Low Health Literacy)**. Los pacientes en este rango tienen una probabilidad cuadruplicada de cometer errores en la administración de psicofármacos o pautas complejas de quimioterapia oral y requieren asistencia verbal directa o pictogramas.

DECISIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO, SEGURIDAD Y BIBLIOGRAFÍA

7. ALGORITMO DE ACTUACIÓN ANTE BAJA ALFABETIZACIÓN OBJETIVA

Paso 1: Aplicación del SAHLSA-50: Administrar los 50 ítems en la consulta o triaje sociosanitario.

Paso 2: Si Puntuación ≥ 38 (Adecuada): Proceder con la entrega de folletos impresos y pautas habituales del servicio.

Paso 3: Si Puntuación ≤ 37 (Baja Alfabetización en Salud):

- **No Confiar en Folletos de Texto Puro:** No entregar documentos con letra pequeña ni consentimiento informado para firma sin lectura guiada paso a paso.
- **Verificación Práctica de Comprensión:** Pedir al paciente que demuestre físicamente cómo abrirá el envase del fármaco y cuántos comprimidos tomará a cada hora.
- **Adaptación Farmacológica:** Solicitar a farmacia hospitalaria o comunitaria la preparación de pastilleros semanales personalizados con etiquetas visuales.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO EN CRIBADO ASISTENCIAL

Identificación: Paciente mujer de 55 años, inmigrante hispanoamericana con 4 años de escolaridad formal básica, atendida en consulta externa de Reumatología por sospecha de artritis reumatoide e indicación de iniciar metotrexato oral semanal.

Evaluación Inicial SAHLSA-50: Puntuación Total = **28 / 50** (Baja Alfabetización en Salud).

- Dificultades observadas: Pronunciaba mecánicamente palabras como "Ictericia" o "Próstata", pero asociaba erróneamente "Ictericia" con "Hinchazón" o elegía "No sé" en términos farmacológicos habituales como "Dosis" o "Comprimido".

Alerta de Seguridad: El metotrexato oral debe tomarse **una sola vez por semana**; si un paciente con baja alfabetización lo toma a diario por confusión, existe un riesgo letal de aplasia medular y mucositis tóxica.

Manejo de Seguridad: Se convocó a su hija como coterapeuta de apoyo, se diseñó un calendario mural con un único círculo rojo en el día semanal de la toma (los lunes) y se verificó telefónicamente a las 2 semanas la correcta adherencia, evitando un error potencialmente fatal.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Banderas Rojas y Riesgos de Medicación:

- **Fármacos de Estrecho Margen Terapéutico:** Anticoagulantes, litio, metotrexato, teofilina o digoxina conllevan riesgo mortal si el paciente tiene ≤ 37 puntos.
- **Consentimiento Viciado:** Una firma en un consentimiento médico complejo en un sujeto con SAHLSA ≤ 37 no garantiza el consentimiento informado real.

Diagnóstico Diferencial:

- **Baja Alfabetización vs. Dislexia / Agnosia Visual:** Descartar problemas oftalmológicos no corregidos (presbicia) que impidan ver las letras de la prueba.
- **Analfabetismo Puro:** Si el sujeto no lee ninguna palabra, no procede aplicar el SAHLSA-50 sino adaptaciones orales puras.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (FORMATO APA 7ª ED.)

- Lee, S. Y. D., Bender, D. E., Ruiz, R. E., & Cho, Y. I. (2006). Development of an easy-to-use Spanish health literacy test. *Health Services Research*, 41(4p1), 1392-1412. <https://doi.org/10.1111/j.1475-6773.2006.00532.x>
- Parker, R. M., Baker, D. W., Williams, M. V., & Nurss, J. R. (1995). The test of functional health literacy in adults: a new instrument for measuring patients' literacy skills. *Journal of General Internal Medicine*, 10(10), 537-541.
- Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ). (2010). **Short Assessment of Health Literacy for Spanish Adults (SAHLSA-50)**. U.S. Department of Health and Human Services.
- Davis, T. C., Long, S. W., Jackson, R. H., Mayeaux, E. J., George, R. B., Murphy, P. W., & Crouch, M. A. (1993). Rapid estimate of adult literacy in medicine: a shortened screening instrument. *Family Medicine*, 25(6), 391-395.